

CAPÍTULO 11.8

Hipertensión e Hipervolemia en la Insuficiencia Renal Crónica

PERFIL EUNACOM 1.06.1.009
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Síndrome Hemolítico Urémico (SHU)

> Causa importante de **IRA intrínseca en niños**. Alta mortalidad si no se detecta a tiempo.

Causa

- **Agente:** *E. coli* enterohemorrágica (**O157:H7**) → produce **verotoxina / toxina Shiga**.
- También: Shigella, Micoplasma (más raros).

Clínica (Tríada Clásica)

TABLA 11.8.1: COMPONENTE VS DETALLE	
COMPONENTE	DETALLE
IRA grave (↑ creatinina, oliguria)	Microangiopatía → necrosis renal
Anemia hemolítica microangiopática	↓ Hematocrito, ictericia
Trombocitopenia	Microangiopatía → consumo de plaquetas

- Antecedente de **diarrea (a veces disentérica)** en el 70% de los casos (semanas previas). - Síntomas neurológicos: compromiso de conciencia, convulsiones, irritabilidad. - Edad más frecuente: **2-5 años** (también lactantes).

Diagnóstico

- Hemograma: **↓ Hematocrito + ↓ Plaquetas** (en IRA prerrenal esas dos cosas *aumentan*).
- Función renal: creatinina elevada.
- FENa elevada + sedimento de IRA renal.
- Ictericia por hemólisis.

SHU vs. IRA Prerrenal — Diagnóstico Diferencial

TABLA 11.8.2: PARÁMETRO VS IRA PRERRENAL		
PARÁMETRO	IRA PRERRENAL	SHU
Hematocrito	↑ (hemoconcentración)	↓ (anemia hemolítica)
Plaquetas	↑ o normal	↓ (trombocitopenia)
Presión arterial	↓ (hipovolemia)	↑ (hipervolemia)
Volemia	Hipovolemia / deshidratación	Edema (parpebral o EEII)
Ictericia	No	Sí (hemólisis)

Tratamiento

- **Soporte intensivo:** hidratación, control de electrolitos.
- **Diálisis de urgencia** si síndrome urémico establecido o complicación grave refractaria.
- **NO usar ATB** (empeoran la liberación de toxina Shiga).
- Pronóstico: hasta 90% revierte por completo con manejo de soporte.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente con IRC etapa 4 y edema de extremidades inferiores presenta presión arterial de 155/95 mmHg. Está en tratamiento con enalapril. ¿Cuál es la conducta más adecuada para lograr el objetivo de presión arterial?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Hipertensión e Hipervolemia en la Insuficiencia Renal Crónica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La IRC produce hipervolemia por retención de volumen: edema, HTA, EPA.
- Manejo: restricción hidrosalina + diuréticos para excretar sodio y agua.
- Objetivo de PA en IRC: SIEMPRE bajo 130/80 mmHg (más estricto que HTA esencial).
- Los diuréticos son especialmente útiles en HTA por IRC porque la fisiopatología es retención de agua.
- En EPA + IRC: furosemida es fármaco fundamental por la hipervolemia de base.
- Riesgo de diuréticos: IRA prerrenal por hipovolemia excesiva (creatinina sube).
- Riesgo de diuréticos: agravamiento de hiponatremia preexistente en IRC.
- Si la creatinina sube con diurético, pensar primero en prerrenal por el diurético.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (HIPERTENSIÓN E HIPERVOLEMIA EN LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA)

PREGUNTA 1

Paciente con IRC etapa 4 y edema de extremidades inferiores presenta presión arterial de 155/95 mmHg. Está en tratamiento con enalapril. ¿Cuál es la conducta más adecuada para lograr el objetivo de presión arterial?

- A)** Aumentar solo la dosis de enalapril
- B)** Agregar un diurético (hidroclorotiazida o furosemida)
- C)** Tolerar hasta 140/90 como objetivo en este paciente
- D)** Suspender enalapril y dejar solo amlodipino
- E)** No hacer cambios, las presiones son aceptables

PREGUNTA 2

Paciente con IRC en tratamiento con furosemida presenta elevación de creatinina de 2.5 a 3.8 mg/dL en una semana. ¿Cuál es la primera hipótesis diagnóstica?

- A)** Progresión natural de la IRC
- B)** IRA prerrenal por hipovolemia secundaria al diurético
- C)** Necrosis tubular aguda
- D)** Nefritis intersticial por furosemida
- E)** Obstrucción urinaria aguda

PREGUNTA 3

¿Cuál es el objetivo de presión arterial en un paciente con insuficiencia renal crónica?

- A)** Menor a 140/90 mmHg
- B)** Menor a 130/80 mmHg
- C)** Menor a 120/80 mmHg
- D)** Menor a 150/90 mmHg
- E)** Depende del estadio de la IRC

RESUMEN: HIPERTENSIÓN E HIPERVOLEMIA EN LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

Esta clase aborda la hipertensión y la hipervolemia como complicaciones de la insuficiencia renal crónica. La fisiopatología es que al caer la filtración glomerular se retiene volumen, manifestándose como edema, hipertensión arterial e incluso edema pulmonar agudo en casos graves. El manejo incluye restricción hidrosalina y diuréticos para excretar sodio y agua. En la IRC, el objetivo de presión arterial siempre debe ser bajo 130/80 mmHg, a diferencia de la hipertensión esencial donde a veces se tolera hasta 140/90. Los diuréticos son especialmente útiles aquí porque la fisiopatología incluye retención de agua. En el edema pulmonar agudo en contexto de IRC, la furosemida cumple un rol fundamental porque hay hipervolemia de base. Los riesgos de los diuréticos incluyen IRA prerrenal por hipovolemia excesiva y agravamiento de la hiponatremia.